

41 - Utérus Cicatriciel - Pr. AIT BENKADDOUR

(0:03 - 0:51)

Ceci est un cours destiné aux étudiants de 5ème année des études médicales de la Faculté de médecine de pharmacie de Marrakech dans le cadre du module de gynécologie obstétrique. Il s'agit du cours sur l'utérus cicatriciel qui est un chapitre très important vu le nombre de plus en plus augmenté de l'utérus cicatriciel dans la pratique obstétrique en raison de l'augmentation des taux de césarienne et de chirurgie sur l'utérus. L'utérus cicatriciel est défini comme étant tout utérus porteur d'une plaie survenant pendant ou en dehors de la grossesse et ayant intéressé en partie ou en totalité la paroi utérine ou le col de l'utérus.

(0:51 - 1:39)

C'est une situation fréquente en obstétrique du fait, comme on a dit, de l'élévation des taux de césarienne, mais aussi de la fréquence de plus en plus élevée de la chirurgie sur l'utérus, que ce soit par voie laparoscopique, par voie hystéroscopique ou aussi par voie conventionnelle de la parotome. L'accouchement sur un utérus porteur d'une cicatrice est un accouchement à risque vu le risque essentiel de rupture utérine avec des conséquences materno-fétales, parfois très graves. En pratique obstétricale, il y a un taux élevé de césarienne systématique, c'est à dire de faire césarienne systématiquement chez toutes les femmes porteuses d'un utérus cicatriciel.

(1:41 - 3:23)

Malgré que cette pratique ne soit pas fondée sur des bases scientifiques solides et que l'accouchement par voie basse reste possible sans augmenter les risques materno-fétales, en respectant, bien sûr, une méthodologie de sélection des patients qui repose sur la définition des critères de choix du mode d'accouchement et en respectant les conditions strictes de l'épreuve utérine. Avant de passer au vif du sujet, quelques mots de terminologie à connaître afin de pouvoir échanger entre collègues sur ce type de pathologie et de situation obstétrique. On parle de césarienne itérative lorsqu'on fait des césariennes sur utérus cicatriciel, qu'elles soient systématiques ou non.

On parle d'épreuve utérine lorsqu'on tente de faire un accouchement par voie basse chez une patiente porteuse d'un utérus cicatriciel. On parle de rupture utérine lorsque, de manière accidentelle, survient une solution de continuité de toute la paroi utérine et qui va faire communiquer la cavité amniotique avec la cavité abdominale. Une forme de cette rupture utérine est la déhiscence utérine, qui correspond à une rupture sous-péritoniale, c'est-à-dire avec une serreuse qui reste intacte, condition qui est de plus bon pronostic que la rupture franche intéressant tous les éléments de la paroi utérine.

(3:32 - 4:01)

Sur le plan épidémiologique, la fréquence de l'utérus cicatriciel est de plus en plus importante. Actuellement, on parle de 5 à 10%, mais elle est en augmentation du fait de l'augmentation du taux de césarienne. Les étiologies ou les causes de l'utérus cicatriciel sont principalement obstétricales, avec 95% des cas des cicatrices de césarienne, plus rarement dans 1% des cas des cicatrices de rupture utérine.

(4:02 - 4:40)

Les cicatrices gynécologiques sont plutôt de bons pronostics, mais sont moins fréquentes. Il s'agit de toute chirurgie portant sur la paroi utérine, que ce soit les myomectomies, les hystéroplasties d'agrandissement qui peuvent être faites soit par hystéroscopie ou par cellioscopie ou par la parotomie. Sur le plan clinique, le principal objectif de l'étude de l'utérus cicatriciel, c'est pour répondre à la question clé face à une patiente qui a un utérus cicatriciel.

(4:40 - 5:23)

Est-ce qu'elle va pouvoir accoucher par voie basse ou bien il faut faire une césarienne itérative? Ceci est basé sur un raisonnement qui va essayer d'évaluer le niveau de risque, surtout de risque de rupture utérine au cours du travail ou de la grossesse. Et ceci est basé sur l'évaluation clinique et paraclinique de la cicatrice utérine, comme on va le voir, puis l'évaluation clinique et paraclinique des conditions obstétricales. Et en associant ces deux grands facteurs, on va essayer de choisir le mode d'accouchement de la patiente, soit faire une césarienne systématique ou bien faire ce qu'on appelle une épreuve utérine, c'est à dire une tentative d'accouchement par voie basse.

(5:25 - 5:38)

Premier volet, c'est l'évaluation de la cicatrice et qui est essentiellement clinique. On verra qu'il y a des éléments paracliniques, mais qui sont moins importants. C'est d'abord étudié par l'interrogatoire la nature de la cicatrice.

(5:38 - 6:32)

Est-ce qu'elle est obstétricale? Est-ce que c'est une cicatrice de césarienne ou cicatrice de myomectomie gynécologique qui, en général, est de plus bon pronostic? Sauf dans les cas où on a fait une polomyomectomie avec délabrement du muscle utérin. La cicatrice de rupture utérine est bien évidemment une cicatrice de très mauvaise qualité et qui va indiquer d'emblée la réalisation d'une césarienne systématique avant le travail. Le type d'hystérotomie, c'est-à-dire de l'incision utérine qui a été réalisée lors de la chirurgie précédente, est très important, puisque lorsqu'on a réalisé une césarienne segmentaire transversale, c'est une cicatrice de bonne qualité, contrairement à l'incision corporeale ou segmentocorporeale, c'est-à-dire segmentaire étendue au niveau du corps, qui est une cicatrice de mauvaise qualité.

(6:33 - 7:06)

Les indications aussi vont jouer un rôle, puisque lorsqu'on fait des césariennes avant le terme, surtout de manière très précoce, le segment inférieur n'étant pas encore formé, il s'agit souvent d'incisions corporeales. La même chose quand on fait des césariennes sur présentation transverse, le segment inférieur est en général mal amplifié et l'extraction est parfois difficile. De ce fait, l'extension corporeale est très fréquente.

(7:06 - 7:42)

La technique opératoire est normalement, on doit disposer d'un compte-rendu opératoire de la césarienne ou de la chirurgie utérine réalisée pour voir le siège de la cicatrice et le type de suture. On interroge aussi les patientes pour savoir les modalités des suites post-opératoires, est-ce qu'il y a eu une infection ou autre complication. Élément important aussi, il s'agit du délai intergénéscique, puisque la durée pour la stabilité de la cicatrisation est d'au moins trois mois.

(7:42 - 8:02)

De ce fait, toute patiente qui est enceinte dans les trois mois suivant une césarienne se voit avoir un risque élevé de rupture même au cours de la grossesse. De ce fait, c'est une grossesse à très haut risque. Au-delà de six mois, en général, la cicatrice est de bonne qualité.

(8:04 - 8:22)

Lorsque le délai intergénéscique est supérieur à six mois, la possibilité d'accouchement par voie basse est très raisonnable. Moins de six mois, il y a un risque de rupture au cours du travail. De ce fait, on réalise des césariennes systématiques avant le travail.

(8:22 - 8:37)

Le nombre de cicatrices est aussi un élément important. L'utérus monocatriciel ne constitue pas une contre-indication à la voie basse. L'utérus tricatriciel et plus est une indication systématique.

(8:38 - 8:53)

L'utérus bicatriciel est globalement, en général, une indication de césarienne. Sauf que dans certaines situations, l'accouchement par voie basse peut être réalisé sous des conditions très, très, très strictes.